

23 - 05-La douleur thoracique - Pr A. BENJELLOUN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salat wa salam ala rasul Allah wa alihi wa sahbihi wa ajma'in
Chers étudiants, nous allons continuer dans notre série de cours sur la sémiologie respiratoire. Le cours d'aujourd'hui s'intitule la douleur thoracique. Les objectifs de ce cours, c'est bien entendu identifier les douleurs thoraciques aiguës et les distinguer des douleurs thoraciques chroniques.

Ce ne sont pas les mêmes étiologies. Savoir décrire et analyser une douleur thoracique pour en connaître la cause et puis énumérer les principales étiologies des douleurs thoraciques. Dans les douleurs thoraciques, les plus importantes, c'est bien sûr les urgences vitales.

C'est ce qu'il faut éliminer en premier. La première, bien entendu, et la plus fréquente, c'est le syndrome coronarien aigu. Quand on parle de syndrome coronarien aigu, c'est l'infarctus du myocarde ou l'engor instable.

C'est un diagnostic qu'il ne faut absolument pas méconnaître. C'est une urgence vitale. Il y a également l'embolie pulmonaire.

Il y a le pneumothorax compressif. C'est une douleur thoracique accompagnée d'une dyspnée importante. C'est un pneumothorax qu'il faut drainer en toute urgence.

Et la tamponade. La tamponade, c'est un épanchement péricardique très important qu'il faut drainer également. La dissection aortique, c'est une maladie qui est très grave et très, très urgente.

Et la perforation esophagienne. Il y a certaines, donc les étiologies les plus fréquentes. C'est bien sûr le syndrome coronarien aigu.

Les douleurs esophagiennes, surtout dans les reflux gastroesophagiens, accompagnées d'un pyrosis. C'est une brûlure étrosternale. Il y a également les attaques de panique, mais ça reste quand même un diagnostic d'élimination.

Et vous avez les douleurs mécaniques qui sont très, très fréquentes. En particulier la syphoscoliose qui est assez fréquente au Maroc. Il ne faut pas méconnaître l'origine extraterrestre des douleurs thoraciques.

Comme les douleurs de la vésicule biliaire. Comme dans la litiase vésiculaire du canal cystique. Ou la cholecystite.

Ou alors la litiase de la voie biliaire principale. Ce sont des douleurs qui irradient au niveau scapulaire, homolatéral. Il y a également les douleurs d'origine thoracique à projection extraterrestre.

Comme les douleurs pleurales qui sont projetées dans l'hypocondre du même côté. Les douleurs aiguës, ça n'a pas été codifié, ça dure entre quelques minutes à quelques heures. Les douleurs chroniques en général c'est plusieurs jours, voire plusieurs mois.

Il faut savoir que dans le poumon, il n'y a que la plèvre qui est douloureuse. Donc lorsque vous avez une douleur thoracique, le poumon ne fait pas mal. Donc il faut chercher une origine pariétale.

Soit la plèvre, soit les côtes, donc la paroi thoracique en général. Afin de décrire la douleur, on va d'abord décrire l'irradiation de la douleur à l'interrogatoire. Le syndrome coronarien aigu irradie vers le cou, la mâchoire et le bras, surtout à gauche.

La dissection aortique et la pancréatite irradient. Les douleurs irradient dans le dos, ce qu'on appelle les douleurs transfixantes, en ceinture. Les atteintes du plexus brachial, c'est le membre supérieur homolatéral.

L'atteinte pleurale irradie à l'épaule et l'hypocondre homolatéraux. L'ozène et les douleurs neurogènes prennent un trajet intercostal. En général, ce sont des douleurs qui sont faciles à reconnaître.

Ce sont des douleurs de type neurogène. Ce sont comme de l'électricité ou des brûlures, et qui irradient en général sur un trajet intercostal, donc vers le dos. La localisation de la douleur également.

Quand elle est rétrosternale, il faut penser à une douleur cardiaque ou médiastinale. Les douleurs esophagiennes sont médiastinales. La douleur latérotorastique, il faut penser à une origine pleurale ou pleuro-parenchymateuse, comme dans les pneumopathies.

La localisation scapulaire, il faut penser aux organes sous-diaphragmatiques, la vésicule, le foie, la rate, ou les sommets pulmonaires. Il faut préciser également l'étendue de la douleur. Le syndrome coronarien aiguë, c'est une douleur qui est étendue.

Ce sont des prêtes cordiales qui irradient à tous les mitorax. Les douleurs pleurales, pariétales et psychogènes sont plutôt localisées, surtout les douleurs psychogènes. Il faut préciser également le type de la douleur.

Le syndrome coronarien aiguë, c'est une oppression diffuse au niveau du thorax, accompagnée en général de sueurs, d'angoisse, et parfois de signes digestifs. La douleur pleurale est plutôt localisée en coups de poignard. L'interrogatoire va également préciser l'intensité et la variabilité dans le nicténaire, ou de jour en jour.

La dissection aortique, c'est une douleur atroce. Elle est maximale d'emblée. C'est une douleur effrayante.

Les douleurs pleurales peuvent être intenses au début, avant que l'épanchement pleural ne soit abondant. L'inspiration majore les douleurs pleurales et péricardiques. Donc si vous avez une douleur qui est majorée à l'inspiration, il faut penser à la plèvre ou au péricard.

La position penchée en avant majore les douleurs péricardiques et le reflux gastro-œsophagien. Le patient vous dit typiquement, j'ai des douleurs quand je fais ma prière. L'atout majeur les douleurs pleurales, vertébrales et pariétales, parce qu'elles sollicitent le diaphragme.

L'ingestion alimentaire modifie les douleurs œsophagiennes et gastriques. Soit elle les augmente, soit elle les soulève. Il faut préciser également la durée de ces douleurs.

Les précordialgies, surtout du syndrome coronarien aigu, sont des douleurs brèves qui durent quelques secondes et qui sont répétitives. L'engor peut durer quelques minutes. D'autres douleurs peuvent durer des heures ou des jours avec des intensités variables.

Il faut préciser également les circonstances déclenchantes. Un engor dit stable est déclenché par l'effort. La rupture œsophagienne est déclenchée par l'évomisement, surtout chez les personnes âgées, fragiles.

Les fractures de côte sont faciles à reconnaître. Elles font suite à un traumatisme ou à un gros effort de tout. Et d'autres douleurs sont spontanées.

L'interrogatoire va préciser également les signes généraux accompagnateurs. L'altération de l'état général doit faire penser au cancer bronchique ou parfois à la tuberculose. Les signes associés respiratoires, il faut les rechercher.

Toux, expectoration, dyspnée, hémoptysie. Les signes infectieux qui orientent vers une pneumopathie, la fièvre et les frissons. Les signes vasculaires, la douleur d'un membre inférieur doit faire penser à la phlébite et donc à l'embolie pulmonaire.

Les signes digestifs accompagnateurs, les vomissements, la dysphagie et les mathémèses doivent faire rechercher une origine œsophagienne ou gastrique. Les signes neurologiques comme les syncope, les lipotinie doivent faire rechercher une origine vasculaire. Les antécédents doivent être précisés, en particulier cardiovasculaires, digestifs respiratoires, thromboemboliques et bien entendu les facteurs de risque cardiovasculaires et thromboemboliques.

Donc c'est une observation totale. Il faut intégrer la douleur thoracique dans un ensemble qui est précisé à l'interrogatoire et à l'examen clinique. L'examen clinique va rechercher surtout les signes de gravité.

Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut éliminer d'abord les urgences, le syndrome coronarien aigu, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire. Il faut rechercher un état de choc, une tachycardie, une hypotension, des signes neurologiques. Il faut chercher l'insuffisance respiratoire aiguë et rechercher également la syncope, la lipotinie qui accompagnent les origines

cardiovasculaires.

L'examen clinique doit faire rechercher les signes cardiovasculaires à proprement parler. On cherche l'insuffisance cardiaque droite, la thrombose veineuse en pensant à l'embolie pulmonaire ou à la tamponade. L'absence d'un pouls ou la différence de tension artérielle entre les deux bras sont caractéristiques d'une dissection aortique.

Des crépitations à l'auscultation sont évocateurs d'un œdème pulmonaire, donc doivent faire rechercher un infarctus du myocarde. Un frottement péricardique peut être évocateur d'une péricardite virale ou d'origine autre. Un souffle diastolique d'insuffisance aortique est un signe de dissection.

Un souffle systolique d'insuffisance mitrale d'apparition récente doit faire rechercher un infarctus du myocarde. C'est une atteinte de la valve par l'ischémie myocardique. Et l'existence d'un syndrome CAV supérieur, à savoir un œdème du visage, une turgescence jugulaire, un œdème en pèlerine, doit faire rechercher une compression de la veine CAV supérieure par une tumeur médiastine, surtout chez les sujets tabagiques.

On recherche également les signes respiratoires. Des crépitations localisés sont évocateurs de pneumopathie. Un silence auscultatoire accompagné d'une matité doit faire rechercher une pluraisie.

Un silence auscultatoire avec un tympanisme sont évocateurs de pneumothorax. Des signes neurologiques comme l'hémiplégie ou l'hémi-parésie doivent faire rechercher la dissection aortique. Le zona intercostal donne des éruptions concomitantes ou qui suivent immédiatement les douleurs thoraciques.

Et puis rechercher les signes pariétaux. Lorsque vous reproduisez une douleur à la palpation, il y a de fortes chances que cette douleur soit pariétale. Sauf dans l'infarctus pulmonaire, dans l'embolie pulmonaire, vous pouvez reproduire parfois la douleur à la palpation.

Quelles sont les causes de ces douleurs ? Alors, les douleurs thoraciques aiguës, il y a le syndrome coronarien, l'infarctus du myocarde, le syndrome de menace qu'on appelle l'engorgement instable. Il s'agit d'une urgence, c'est une douleur qui irradie aux membres supérieurs, aux épaules et à la mâchoire. Elle n'est pas maximale d'emblée, elle est volontiers progressive.

Elle n'est pas modifiée par l'inspiration, contrairement aux douleurs pleurales ou péricardie. Elle n'est pas modifiée par la toux et les changements de position. La dissection aortique, il faut absolument la connaître et la reconnaître.

Il s'agit d'une fissuration de l'intima aortique et création d'un faux chenal dans l'épaisseur de la paroi. Donc vous avez le flux sanguin qui pénètre à l'intérieur de la paroi aortique. Et c'est une maladie très, très dangereuse.

On la voit surtout chez les sujets âgés, apéromateux ou dans certaines maladies génétiques du tissu conjonctif, comme la maladie de Marfan ou la maladie de Herner dans l'os. C'est une douleur intense, d'emblée maximale, d'accord. Le patient, il sent qu'il va mourir.

C'est une douleur qui est vraiment très, très importante. C'est une douleur médiane, rétrosternale, qui peut irradier dans le dos. On remarque parfois, ça dépend du niveau de la dissection aortique.

On peut avoir un déficit neurologique, une différence de tension artérielle entre les deux bras, l'absence d'un pouls ou un souffle diastolique à l'auscultation cardiaque. L'embolie pulmonaire donne une douleur de type pleural d'intensité variable qui varie au changement de position ou à l'un de tous. Et il y a parfois des signes associés, mais qui ne sont pas spécifiques.

La dyspnée, les hémoptysies, surtout lors d'infarctus pulmonaire, la fièvre, la toux, une syncope, la tachycardie est pratiquement constante. Il faut rechercher une phlébite à l'examen clinique ou même à l'échodoplaire des membres inférieurs. Mais la phlébite est inconstante.

Il faut bien entendu rechercher les facteurs de risque thrombomoboliques. Il faut établir ce qu'on appelle le score de Genève. Il y a aussi d'autres scores, comme le score de Wells.

C'est un score de probabilité de l'embolie pulmonaire. Dans ce score, vous avez plusieurs paramètres, comme la chirurgie récente, le traumatisme, le cancer, un traitement hormonal, et l'immobilisation sont tous des facteurs de risque de maladie thrombomobolique. On recherche également les signes de gravité qui nécessitent un traitement d'urgence, comme l'état de choc, l'insuffisance cardiaque droite.

La rupture de l'osophage est heureusement rare et survient surtout chez les personnes âgées. C'est une douleur rétrosternale précédée de vomissements. C'est les vomissements qui déclenchent cette rupture osophage.

Le pneumothorax en général est facile à reconnaître. C'est une douleur pleurale latérotoracique à début brutal, parfois accompagnée de dyspnées lorsque le pneumothorax est abondant. Ce pneumothorax peut être spontané chez un sujet sain, en général longiligne et fumeur, ou pathologique, lorsque vous avez une rupture de bulles d'amphizème chez les BPCO.

Elle peut être secondaire, par exemple suite à un accident de la circulation, ou iatrogène, lorsque le médecin fait une ponction pleurale pour un épanchement liquidien. Il peut traumatiser le poumon et faire un pneumothorax. On voit aussi des pneumothorax lorsqu'on fait des voies vénus centrales sous clavière.

Le pneumothorax suffocant est une urgence thérapeutique qu'il faut absolument drainer. D'autres douleurs thoraciques aiguës, vous avez les pneumonies. C'est une douleur plutôt de type pleurale avec fièvre, frisson, toux, expectoration purulente, parfois rouillée.

La rouille, c'est une hémoptysie, mais de faible abondance. On peut avoir parfois un herpès labial, mais ce n'est pas spécifique. L'herpès, on peut le voir lorsque vous avez une fièvre importante.

On entend les crépitants à l'auscultation, un peu plus rarement un souffle tubaire, ce qu'on appelle un syndrome de condensation. Il faut rechercher les signes de gravité qui doivent faire imposer une hospitalisation comme l'hypotension, la polypnée ou les troubles de la conscience. La radiographie thoracique doit être faite de manière systématique pour asseoir le diagnostic et débiter un traitement.

La péricardite donne une douleur rétrosternale qui peut irradier dans le dos et les épaules. Elle est aggravée par l'inspiration comme les douleurs pleurales et aggravée également par le décubitus dorsal. Elle est soulagée par la position penchée en avant comme le reflux gastro-ösophagien.

On peut avoir une dyspnée des signes généraux, surtout lorsque vous avez un épanchement péricardique important. Il faut rechercher les signes de gravité, les signes d'insuffisance cardiaque droite par compression du ventricule droit. En général, c'est une tamponade.

L'épanchement est très important et il faut le drainer rapidement. Le diagnostic se fait à l'échographie cardiaque, mais vous pouvez déjà le voir à la radiographie thoracique ou éventuellement au scanner si vous n'avez pas d'échographie cardiaque. La pleurésie est plutôt douloureuse lorsqu'elle est minime, mais lorsque l'épanchement est plus abondant, on a surtout de la dyspnée et la douleur disparaît.

C'est une douleur latérotoracique majorée par l'inspiration et l'atout et soulagée par le décubitus latéral du côté de la lésion. Si vous avez une lésion à droite, elle est soulagée par le décubitus latéral droit. Elle peut irradier à l'épaule ou à l'hypocondre homolatéral.

Les signes associés à la douleur thoracique sont variables en fonction de l'étiologie. Les douleurs digestives, surtout le reflux gastro-ösophagien, sont très fréquents au Maroc. Vous en retrouverez facilement.

Il suffit de le chercher. Le reflux, l'ösophagite, la pancréatite aiguë, l'ulcère gastrique sont autant d'étiologies de douleurs thoraciques aiguës. Les douleurs osophagiennes sont plutôt rétrosternales.

Elles peuvent irradier dans le cou, majorées par la position penchée en avant, parfois au décubitus. Les patients vous décrivent une douleur ou même une gêne pharyngée lorsqu'ils sont en position allongée. Il faut d'abord éliminer un syndrome coronarien aigu avant de conclure un reflux.

Les douleurs pariétales sont faciles à reconnaître, surtout les fractures costales. Le contexte est

connu. C'est un contexte traumatique.

La douleur est très intense. Elle est majorée à l'aspiration et reproductible à la palpation. Vous avez également les douleurs musculaires intercostales, les névralgies, les douleurs controcostales.

Ce sont des diagnostics d'élimination qui sont faciles à faire. Et bien entendu, vous avez les douleurs psychogènes. Ce sont des douleurs très localisées, migratrices et récidivantes.

En général, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais ça reste un diagnostic d'élimination. Il faut d'abord faire un bilan pour éliminer les étiologies plus graves.

Dans les douleurs thoraciques chroniques, vous avez également les causes digestives, le reflux gastro-œsophagien. Quand il est méconnu, vous avez des douleurs chroniques. La pancréatite chronique et le cancer du pancréas, surtout chez le sujet éthylique.

Ce sont des douleurs qui irradient dans le dos. Le cancer de l'œsophage, c'est une douleur accompagnée de dysphagie. Les lithiases biliaires évoluent par crise en général.

Ce sont des irradiations à l'épaule droite. Les douleurs chroniques peuvent être pariétales, surtout les douleurs costales, vertébrales et neurologiques. Elles peuvent être mécaniques, qui surviennent à l'effort ou au mouvement, ou inflammatoires, qui réveillent la nuit.

Quand elles sont inflammatoires, il faut penser en priorité à des métastases. Des problèmes de statique vertébrale, vous trouverez très souvent au Maroc des syphoscolioses. C'est une maladie qui est congénitale.

On naît avec une syphoscoliose. Il faut savoir la rechercher par l'asymétrie des pointes de l'homoplate. Et puis vous avez les douleurs neurogènes, souvent dues au zona.

Ce sont des douleurs qui persistent après le zona, et qui sont très difficiles à traiter. On donne en général des psychotropes pour les soulager. Là, vous avez des exemples de douleurs pariétales.

Là, vous avez une ostéolyse de la deuxième côte. Là, vous avez un morceau de côte qui manque. Ça, c'est une origine néoplasique.

C'est une métastase. Là, vous avez quelque chose de facile. Là, vous avez une fracture de la clavicule.

Là, avec une ostéosynthèse. Là, vous avez un pneumothorax. Là, vous voyez bien.

Là, c'est du paranchyme. On voit les vaisseaux pulmonaires. Là, on ne voit rien.

C'est du noir. C'est un pneumothorax. Et là, ce que vous voyez ici, c'est le moignon pulmonaire qui est ratatiné contre l'huile par l'air qui a pénétré à l'intérieur de la paroi thoracique.

Là, vous avez une pneumonie aiguë qui est aussi une cause de douleurs thoraciques. Là, vous voyez, c'est une pneumonie du poumon droit, précisément du lobe moyen. Là, on la voit au niveau du scanner thoracique.

Là, vous avez une image d'embolie pulmonaire. Là, regardez, vous avez un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire droite. C'est ce qu'il y a en noir.

Et vous avez un autre thrombus au niveau de l'artère pulmonaire gauche. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours? Il faut d'abord éliminer les urgences. Le syndrome coronarien aigu, la dissection aortique, la tamponade, la perforation oesophagienne et le pneumothorax.

Il faut savoir localiser la douleur. Est-ce qu'elle est précordiale ou rétrosternale? Surtout cardiaque. Est-ce qu'elle est plutôt latérale évoquant les douleurs pleurales? Il faut situer son irradiation.

Lorsqu'elle irradie dans la mâchoire, il faut penser à une origine coronarienne dans le dos, plutôt la dissection ou la pancréatique. Quel est le type de douleur et l'étendue? Quand il s'agit d'une oppression, c'est surtout un syndrome coronarien aigu. Un coup de poignard est plutôt évocateur d'une origine pleurale.

L'intensité, la variabilité, la douleur de la dissection aortique est atroce. Lorsque cette douleur est modifiée par le mouvement ou la toux, elle est plutôt pleurale. Quand c'est une douleur déclenchée par la position en avant ou par les repas, c'est plutôt un reflux gastro-oesophagique.

Il faut préciser la durée et les facteurs déclenchants. Lorsqu'elle est brève et déclenchée par l'effort, on pense à l'engorge. Lorsqu'il existe, il faut préciser les signes associés, les signes généraux, digestifs, neurologiques et cardiovasculaires.

L'examen clinique doit être complet, qu'il soit thoracique ou général pour préciser l'étiologie de ces douleurs thoraciques. Je vous remercie.